

Fecha Última Actualización: 11-06-2022 14:36:54

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Segundo Lorenzo Lagos Campos
Edad : 81a 1m 4d
Dirección : Avenida San Carlos 0444

Rut : 4.723.201-5
Fecha Nacto: 07/05/1941
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1021179
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8229 5097

N° Epicrisis
306946

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Hospital De Campaña - Camas Básic **Fecha Ingreso** : 30/01/2022 07:01
Unidad de Egreso : Utim **Fecha Egreso** : 11/06/2022 14:06

Días Estadía: 132

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

COVID-19

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Segundo Lorenzo Lagos Campos
4.723.201-5
81 años

FI HSR: 30/01/22
FI Medicina: 30/01/22
FI UPC: 01/02/2022
FI UTIM: 19/05/2022
Contacto tutor: Lorena Lagos, hija (enfermera pediátrica) 982295097

ANTECEDENTES:

Médicos: DM2NIR, HTA, DLP, Cardiopatía coronaria (SCA 2005, PCI a -no se cuenta con documentación, no sabe-)
Quirúrgicos: OTS pierna derecha (juventud), CBC operado (2014)
Alergias: No
Fármacos: Metformina, losartán, atenolol, atorvastatina, ác. acetilsalicílico, zopiclona
Hábitos: TBQ (suspendido 2005, previamente 2 cajetillas diarias), OH (no), Drogas (no)
Hospitalizaciones recientes: No
Inmunizaciones: COVID (3 dosis) + Influenza 2021
Social: Independiente para AIVD, vive con esposa

HISTORIA ACTUAL

Derivado a UEA CASR el día 30/01/2022 por cuadro de 5 días de evolución de disnea, fiebre y mialgias. Es inicialmente evaluado por HELP en domicilio, indicándose tratamiento sintomático y test de antígeno que resulta positivo. Estuvo en tratamiento con Amoxicilina/Ác. Clavulánico y con prednisona por 3 días. Dado persistencia de síntomas es evaluado nuevamente y destaca SpO2 88% y taquipnea, por lo que se deriva a UEA.

Ingresa a SU CASR normocárdico, levemente hipertenso, subfebril y con req. de O2 por NRC, se describe al examen físico bien hidratado y con crépitos finos bibasales a la auscultación pulmonar. Se traslada inicialmente a unidad básica de medicina, donde se mantiene con O2, broncodilatación, KNTR y dexametasona. Destaca en laboratorio al ingreso leucopenia (linfopenia) y trombocitopenia, que se atribuyen a infección por COVID. El día 01/02 evoluciona con deterioro ventilatorio y disminución de SpO2, requiriendo apoyo con m. de recirculación y luego CNAF con elevados req. de FiO2. Se indica prono y ante no mejoría y

Fecha Epicrisis : 11/06/2022 14:36

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 11-06-2022 14:36:54

Página 2 de 4

persistencia de deterioro, se decide IOT (01/02). Se solicita AngioTC donde no se visualiza TEP, y se describen extensas opacidades parenquimatosas pulmonares bilaterales, además de leve enfisema centroacinar y paraseptal. Se traslada a UPC para continuar tratamiento.

EVOLUCIÓN POR PLANES EN UPC:

Hemodinamia: Al ingreso en UPC se describen bajos req. de DAV que impresionan en relación a sedoanalgesia, sin compromiso de perfusión y con láctico en rango. Posteriormente en relación a disminución de sedación evoluciona con franca adrenergia, agitación y tendencia a la hipertensión, con req. de BIC de labetalol. Logra mejor control de PA con inicio de VDO. Dado persistencia de req. de DVA especialmente ante interurrencias infecciosas (aunque siempre en dosis bajas-moderadas) se solicita cortisol basal (2.6), y se indica curso de hidrocortisona. Evoluciona favorable en cuanto a hemodinamia, con perfusión adecuada y buenos parámetros de microperfusión, sin req. de DVA desde 02/03.

Respiratorio: Ingres a en contexto de insuficiencia respiratoria por COVID, con IOT en contexto de apremio ventilatorio y desaturación pese a CNAF y prono, con req. de sedación profunda y BNM. El 10/02 evoluciona con franco deterioro respiratorio, y con desaturación. Se solicita angioTC donde no se visualiza TEP pero se evidencia acentuado neumotórax derecho con atelectasia subtotal pulmonar y desplazamiento de mediastino, por lo que se solicita instalación de pleurostomía por cirugía (que se retira el 22/02). Completa protocolo Recovery 10/02/2022. TQT percutánea 18/02, sin incidentes. En relación a agitación, miopatía de paciente crítico, interurrencias infecciosas y req. intermitente de DVA, weaning prolongado y destete difícil de VMI. Impresiona fenotipo de EPOC tabáquico, con secuelas pulmonares de NAC por COVID, con dificultad de ventilación en modos espontáneos por miopatía, desacondicionamiento, agitación e insuficiencia respiratoria hipercápnica incluso con retención en presión positiva en modo CPAP por TQT. Logra mejoría sustantiva con entrenamiento, logrando paso a filtro con 2L/O2 por 12-14 horas durante el día, pero requiriendo ventilación nocturna por TQT en modo SIMV en ventilador liviano, bien tolerada, con buen control gasométrico y sin retención de CO2. En ese contexto se plantea ingreso a programa AVIA y rehabilitación domiciliaria.

Infectológico: Cursa con múltiples interurrencias infecciosas durante estadía en UPC, resumen:

NAVM (P. mirabilis MS) = Ampicilina Sulbactam ¿ Linezolid

NAVM (KPN BLEE) = Imipenem

Candidiasis oral = Fluconazol (150 mg. semanal por 3 veces)

NAVM (P. Mirabilis) e ITU (P. vulgaris) = Ceftriaxona

Traqueobronquitis (P. Mirabilis + KPN BLEE) = Imipenem (curso de 10 días)

Traqueobronquitis (E. Coli MS + PSAE MS) = Ceftazidima (curso de 5 días)

ITU (KPN BLEE) = Amikacina

Portador E. faecium Van B (R) a Vancomicina

Metabólico: Requerimiento intermitentes de IC en relación a corticoterapia probablemente. Se inicia esquema de NPH, actualmente adecuado control metabólico.

Nefrológico: Durante estadía en UPC evoluciona con disociación de creatinina/BUN, con BUN francamente elevado, con sospecha de NTA. Se mantiene con diuresis conservada. En relación a mejoría clínica con evolución favorable de función renal. No requiere TRR. Posteriormente sin conflicto

Gastroenterológico: Dado crítico crónico se indica en UPC régimen vía SNG. Evoluciona con trastorno de deglución, realizándose GTT el 28/04, sin incidentes, con nutrición enteral por GTT bien tolerada.

Neurológico: Inicialmente agitación al disminuir sedoanalgesia, lo que prolonga weaning. Posteriormente con disminución de sedoanalgesia se conecta y obedece órdenes simples. Evoluciona con neuropatía de paciente crítico. Sd. confusional agudo intermitente en relación a interurrencias infecciosas, y con inversión de sueño vigilia pese a uso de melatonina y risperidona, por lo que se indica zopiclona de uso crónico. Surge importante labilidad emocional y distimia, por lo que se inicia sertralina. Evaluado por Medicina Física y Rehabilitación, indican buen pronóstico de activación motora global, con pies equinos que limitarán transferencias y deambulaci3n.

Rehabilitaci3n:

FNA: Tr. de degluci3n en seguimiento por equipo de FNA, evaluado por ORL con parálisis de cuerda vocal. Con indicaci3n de régimen 0 por boca.

TO: Evaluado por fisiatría, sugieren entrenamiento por TO de actividades que involucren coordinaci3n de EESS y manipulaci3n

Fecha Epicrisis : 11/06/2022 14:36

Página 2 de 4

bimanual.

EVOLUCIÓN UTIM:

- HDN: Paciente con requerimientos de DVA en dosis bajas en contexto de nueva intercurrente infecciosa, suspendidas 07/06 por última vez. Posteriormente con hemodinamia autosostenida, sin requerimientos de VDO.
- Respiratorio: Paciente crítico crónico, portador de TQT sin posibilidad de decanulación en relación a parálisis cordal izq, neuromiopatía del paciente crítico e intercurrentes infecciosas respiratorias múltiples. Presenta nuevo hit infeccioso respiratorio desde 30/05 aumentando requerimientos de ventilador durante el día y asociado a fenómenos que impresionan microaspirativos. Buena respuesta a manejo antibiótico y finalmente a cambio de cánula (08/06 se cambia a tubo 9.0) logrando buena oclusión. Se mantiene en rehabilitación con válvula IMT, con mejor mecánica ventilatoria. Durante el día requiriendo 2 L y en noche con conexión a VMNI a 16/7. Últimas 2 noches conectado a ventilador propio que trae familia.
- Infectológico: Último hit 30/05 - 04/06: NAAS por KPN BLEE y Proteus MS en CAET, con HC negativos. Luego de cambio de cánula con franca mejoría de lo respiratorio, 09/06 suspende ATB con imipenem (completó 12 días). PI a la baja y menor cantidad de secreciones.
- Neurológico: Con buen nivel de conciencia, se inicia risperidona para manejo de insomnio (quetiapina mal tolerada)
- Nutricional: Recibiendo NE a 60 cc/h. Pendiente evaluación por especialidad para pauta de alimentación previo alta (ya solicitado)
- Rehabilitación: Paciente crítico crónico, con tr. de deglución y miopatía/neuropatía del paciente crítico en rehabilitación. En plan de egreso con soporte VMNI por TQT (nocturno) por no decanulación y tendencia a la retención de PCO2 en contexto de compromiso miopático.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO:

- 1. Paciente crítico crónico:
- Neuropatía y miopatía del paciente crítico
- Insuficiencia respiratoria en contexto de miopatía, VMNI nocturna por TQT
- Tr. de deglución en rehabilitación por FNA= Parálisis Cordal Izq
- UPP glútea grado I

RESUELTOS:

- NAAS KPN BLEE + P mirabilis MS = imipenem 12 días
- Neumotórax espontáneo a tensión con desplazamiento mediastínico
- NAVM (P. mirabilis MS) = Ampicilina Sulbactam ¿ Linezolid
- NAVM (KPN BLEE) = Imipenem
- Candidiasis oral = Fluconazol (150 mg. semanal por 3 veces)
- NAVM (P. Mirabilis) e ITU (P. vulgaris) = Ceftriaxona
- Traqueobronquitis (P. Mirabilis + KPN BLEE) = Imipenem (curso de 10 días)
- Traqueobronquitis (E. Coli MS + PSAE MS) = Ceftazidima (curso de 5 días)
- ITU (KPN BLEE) = Amikacina
- Neumonía Grave por COVID 19.
- Antecedentes: DMNIR, HTA, Cardiopatía coronaria (PCI en 2005, no se cuenta con documentación)

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria Crónica - Secuelas Covid
Lcfa
Disfagia Moderada -
Diabetes Mellitus 2 - Insulinorequiriente
Infarto Antiguo Del Miocardio -
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) -
Neumonía Asociada a Cuidados de la Salud: NAVM -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

En buenas condiciones generales, afebril por más de 48 horas, con requerimientos bajos de oxígeno diurnos y VM nocturno.
En condiciones de continuar recuperación en domicilio.

INDICACIONES FARMACOLÓGICAS:

Fecha Epicrisis : 11/06/2022 14:36

Paracetamol 1 gr. cada 8 horas por GTT

Ác. Acetilsalicílico 100 mg. cada 24 horas por GTT

Sertralina 50 mg. cada 24 horas por GTT

Melatonina 9 mg. cada 24 horas por GTT (PM)

Risperidona 0,5 mg/noche GTT

Berodual 4 puff cada 6 horas por TQT

Budesonida 2 puff cada 12 horas por TQT

PEG 3350 15 g en 200 cc H2O c/24 h GTT (para mantener 1-2 deposiciones pastosas)

Insulina NPH 10 UI SC (AM)

Plan Post Alta

- >Soporte con O2 suplementario por TQT 3lts. (Presentado a POD, en plan de aporte durante la proxima semana)
- >KNT respiratoria- KNT Motora, Seguimiento FNA
- >Derivacion a programa postrado de APS
- >Conexion Nocturna VMNI ST 16/7
- >Régimen papilla por GTT acorde pauta de nutricion
- >Activacion motora - sentar asistido y pasar a sillón.

Paracetamol 1 gr. cada 8 horas por GTT

Ác. Acetilsalicílico 100 mg. cada 24 horas por GTT

Sertralina 50 mg. cada 24 horas por GTT

Melatonina 9 mg. cada 24 horas por GTT (PM)

Risperidona 0,5 mg/noche GTT

Berodual 4 puff cada 6 horas por TQT

Budesonida 2 puff cada 12 horas por TQT

PEG 3350 15 g en 200 cc H2O c/24 h GTT (para mantener 1-2 deposiciones pastosas)

Insulina NPH 10 UI SC (AM)

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar A Sillon

Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Paula Miranda Berkhoff
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 11/06/2022 14:36

Página 4 de 4